FOIE · FO-02

LI-RADS · échographie et CEUS

US Surveillance v2024 · CEUS v2017
surveillance du CHC et échographie de contraste

ÉCHOGRAPHIE DE SURVEILLANCE · LI-RADS US SURVEILLANCE V2024

Population : cirrhose Child-Pugh A ou B (et C si candidat à la greffe) ; hépatite B chronique sans cirrhose à risque (homme > 40 ans ou femme > 50 ans de zone d'endémie, origine africaine ≥ 20 ans, antécédent familial de CHC, PAGE-B ≥ 10) ; cirrhose virale C guérie (risque ≥ 10 ans). Pas de surveillance systématique en fibrose F3. Rythme : **tous les 6 mois**, en ambulatoire.

Catégorie de l'examen

CATÉGORIE	DÉFINITION	CONDUITE
US-1 négatif	Aucune observation ou seulement bénigne certaine (kyste, stéatose ou épargne focale typique, hémangiome connu, < 10 mm stable sur 2 contrôles)	Échographie à 6 mois
US-2 infra-seuil	Observation(s) **< 10 mm** non certainement bénigne(s)	**2 contrôles à 3–6 mois** ; si stable < 10 mm → US-1
US-3 positif	Observation **≥ 10 mm**, distorsion parenchymateuse ≥ 10 mm, ou **nouveau thrombus** porte ou sus-hépatique	Scanner ou IRM multiphasique, ou CEUS

La catégorie s'applique à l'examen entier (observation la plus suspecte) ; en cas de doute, choisir la plus suspecte.

Score de visualisation

SCORE	DÉFINITION	CONDUITE
VIS-A	Limitations nulles ou minimes	Selon la catégorie US
VIS-B	Limitations modérées pouvant masquer des lésions < 10 mm	Selon la catégorie US (sensibilité > 75 %)
VIS-C	Limitations sévères ; > 50 % du diaphragme ou d'un lobe non vus	**Nouvelle échographie ≤ 3 mois** ; si VIS-C répété ou facteurs de risque (MASH, alcool, Child B/C, IMC ≥ 35) : IRM abrégée, IRM ou scanner

Sensibilité de l'examen VIS-C pour le CHC : < 30 %. Balayages vidéo (« cine sweeps ») recommandés.

AFP élevée avec cible échographique
(≥ 20 ng/mL, doublement ou hausse sur 2 dosages) → scanner, IRM ou CEUS

AFP élevée sans cible
scanner ou IRM multiphasique (pas de CEUS) ; si négatif et AFP ≥ 200 : autre modalité, voire bilan extra-hépatique

ÉCHOGRAPHIE DE CONTRASTE · CEUS LI-RADS V2017

Tableau diagnostique

	PAS DE WASH-OUT	WASH-OUT TARDIF ET MODÉRÉ
Pas d'APHE, < 20 mm	LR-3	LR-3
Pas d'APHE, ≥ 20 mm	LR-3	LR-4
APHE, < 10 mm	LR-3	LR-4
APHE, ≥ 10 mm	LR-4	LR-5

APHE non périphérique et non globulaire discontinu (sinon : hémangiome ou LR-M). Le nodule doit être visible en mode B.

Le wash-out en CEUS

WASH-OUT	SIGNIFICATION
Tardif (≥ 60 s) **et modéré**	Typique du CHC → critère majeur
Précoce (< 60 s)	Évoque un cholangiocarcinome ou une métastase → LR-M
Marqué (lésion « vide » en < 2 min)	

CRITÈRES LR-M

APHE **en anneau**, wash-out précoce ou wash-out marqué

TECHNIQUE

SonoVue (agent intravasculaire pur) : observer jusqu'à **≥ 5 min** ; plusieurs injections possibles pour plusieurs nodules

PIÈGES

Agent
avec un agent à phase de Kupffer (Sonazoid), les règles diffèrent

Wash-out tardif
un wash-out qui devient marqué après 2 min reste « modéré »

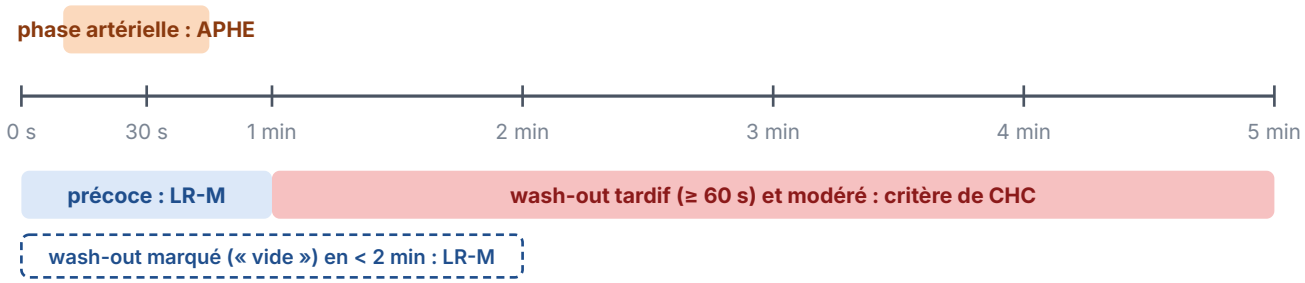
CEUS ≠ scanner/IRM
le CEUS ne fait pas le bilan d'extension : scanner ou IRM restent nécessaires

LR-TIV
tissu rehaussé dans une veine, quel que soit le nodule

LI-RADS · échographie et CEUS (suite)

ATLAS VISUEL

Chronologie du wash-out en CEUS



Observer au moins 5 minutes (SonoVue) · Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

LI-RADS US Surveillance
Radiopaedia · catégories US et VIS
radiopaedia.org/articles/li-rads-us-surveillance

CEUS LI-RADS
Radiopaedia · tableau diagnostique
radiopaedia.org/articles/ceus-li-rads-2

LI-RADS US v2024 (PDF)
Texte de la mise à jour
geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/upl

Sources : LI-RADS US Surveillance v2024 (Radiology 2024) – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · CEUS LI-RADS v2017 Core – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/LI-RADS/CEUS-LI-RADS-2017-... · LI-RADS: Current Status (KJR 2024) – kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348/kjr.2024.0161